

„Albo eksploduję *albo* czuję pustkę”

W C-PTSD okno tolerancji jest wąskie. Cel Fazy 1: poszerzyć je przez ćwiczenia somatyczne i poznawcze. To codzienna, fundamentalna praca.

CZAS: codzienna praktyka 10–20 min **REALIZACJA:** faza 1 stabilizacji, fundament

ŹRÓDŁO: Siegel (1999, *The Developing Mind*); Ogden i in. (2006, *Sensorimotor Psychotherapy*); Levine (1997, *Somatic Experiencing*); Porges (2011); Lanius i in. (2010); van der Kolk i in. (2016, RCT *neurofeedback*)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy strefy** aktywacji: hiperpobudzenie (lęk, gniew, panika), okno tolerancji (jednoczesne czucie i myślenie), hipopobudzenie (odrętwienie, dysocjacja, depresja). W sekcji 02 — **strategie poszerzania** okna: oddech wagotoniczny, pendulacja Levine, mikrodawki trudnego, somatyczne zasoby. Sekcja 03 — **twoja samoobserwacja** stref w ostatnim tygodniu. Sekcja 04 — plan praktyki na 2 tygodnie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Okno tolerancji (Siegel, 1999, *The Developing Mind*) to **strefa optymalnej regulacji** układu nerwowego — między *hiperpobudzeniem* (panika, gniew, dysocjacja agresywna) a *hipopobudzeniem* (odrętwienie, dysocjacja pasywna). W tej strefie można jednocześnie *czuć* emocje i *myśleć* — kora przedczołowa ma dostęp regulacyjny, ciało migdałowe nie jest w trybie alarmu, regulacja *top-down* i *bottom-up* współpracują. W C-PTSD **okno jest często bardzo wąskie** — pacjent oscyluje między hiperpobudzeniem a hipopobudzeniem bez dostępu do strefy optymalnej. Klientka opisuje: „*albo eksploduję, albo czuję pustkę*”. Mechanizm zawężenia: chroniczna trauma przeprogramowuje układ nerwowy do stałego alarmu — ciało migdałowe jest nadreaktywne, kora przedczołowa ma ograniczony dostęp regulacyjny (Lanius i in., 2010). Cel Fazy 1 stabilizacji: **poszerzanie okna tolerancji**. Strategie ewidencjonowane: (a) **oddech wagotoniczny** — wydłużony wydech (4 sekundy wdech, 6–8 wydech) aktywuje nerw błędny (gałąź brzuszna), obniża tętno i kortyzol; (b) **pendulacja** (Levine, 1997, *Somatic Experiencing*) — świadome wahadło między trudnym a zasobem; uczy układ nerwowy, że można bezpiecznie oscylować; (c) **mikrodawki trudnego** (tytulacja) — stopniowe, krótkie kontakty z dyskomfortem (intensywność 2–3/10) z natychmiastowym powrotem do zasobu; habituacja bez zalewania emocjami (ang. *flooding*); (d) **neurofeedback** (van der Kolk i in., 2016, RCT) — ograniczone, ale obiecujące dowody na obniżenie hiperreaktywności ciała migdałowego; (e) **somatyczne zasoby** — regularne ćwiczenia, sen, rytm dobowy jako fundamenty biologiczne okna. Próby pracy z traumą *odgórnie* (np. ekspozycja) *bez* wcześniejszego poszerzania okna natychmiast wybijają poza nie — sesja kończy się dysocjacją lub kryzysem.

01

Trzy strefy aktywacji

HIPERPOBUDZENIE

Eksplodacja. Lęk, panika, gniew, retrospekcje (ang. *flashbacks*), wzmożona czujność, wybuchy. Tętno przyspieszone, oddech płytki. Ucieczka uwagi. *Mózg w trybie alarmu.*

OKNO TOLERANCJI

Strefa optymalna. Można *czuć* emocje (nawet trudne) i *jednocześnie myśleć*. Kora przedczołowa ma dostęp, ciało migdałowe nie jest w alarmie. *W tym stanie odbywa się gojenie.*

HIPOPOBUDZENIE

Wyłączenie. Odrętwienie, dysocjacja, „rozmycie”, brak energii, poczucie nierzeczywistości, depresja. Tętno spowolnione. *Najgłębszy tryb przetrwania — zamrożenie.*

02 Strategie poszerzania okna

A · ODDECH WAGOTONICZNY

Wdech 4 s — wydech 6-8 s. Wydłużony wydech aktywuje gałąź brzuszną nerwu błędnego (Porges, 2011), obniża tętno i kortyzol. 5-10 min dziennie. *Najszybsza i najtańsza interwencja.*

B · PENDULACJA (LEVINE)

Wahadło: trudne ↔ zasób. 30 sek kontaktu z dyskomfortem (intensywność 2-3/10) — 60 sek powrotu do zasobu (bezpieczne miejsce, oddech). Powtórzyć 5-7x. Układ nerwowy uczy się oscylować bezpiecznie.

C · MIKRODAWKI TRUDNEGO

Tytulacja. Stopniowe, krótkie ekspozycje na dyskomfort (2-3/10), z natychmiastowym powrotem do zasobu. *Nie zalewanie emocjami (ang. flooding).* Habitucja bez retraumatyzacji.

D · SOMATYCZNE FUNDAMENTY

Sen, ruch, rytm. Regularne ćwiczenia, sen 7-9 godz., stały rytm dobowy. Fundament biologiczny okna — bez niego pozostałe strategie mają ograniczoną skuteczność.

03 Moja samoobserwacja stref

MOJA DOMINUJĄCA STREFA W TYM TYGODNIU

— *hiperpobudzenie / okno tolerancji / hipopobudzenie; po czym to poznaję*

CO MNIE WYBIJA POZA OKNO

— *wyzwalacze (sytuacje, osoby, dźwięki, własne myśli, godziny dnia)*

CO DZIAŁA, GDY WRACAM DO OKNA

— *sprawdzone strategie regulacji*

MÓJ PLAN PRAKTYKI NA 2 TYGODNIE

— *jedna strategia (oddech / pendulacja / ruch) 10-15 min dziennie*

Klucz: poszerzanie okna tolerancji *nie* jest tłumieniem emocji ani „pozytywnym myśleniem”. To **uczenie układu nerwowego**, że można *czuć* trudne emocje i *jednocześnie* pozostać w kontakcie z teraźniejszością. To biologia — pendulacja, oddech wagotoniczny, mikrodawki działają niezależnie od woli, bo działają na poziomie nerwu błędnego, ciała migdałowatego, osi HPA. Próby pracy z traumą *odgórnie* (ekspozycja, restrukturyzacja poznawcza) *bez* wcześniejszego poszerzania okna są *jatrogeniczne* w C-PTSD — natychmiast wybijają poza okno, sesja kończy się dysocjacją lub kryzysem. Faza 1 to dosłownie *rozszerzanie biologicznej pojemności* regulacji — fundament wszystkich kolejnych faz.

△ *Jeśli twoje obecne strategie radzenia sobie obejmują substancje, samookaleczenie lub inne destrukcyjne mechanizmy — to nie wstyd, to objaw nieadekwatnego okna. Praca: nie eliminować nagle (bez zamiennika destabilizuje), ale stopniowo zastępować strategiami poszerzającymi okno. Rozmowa z terapeutą jest tu kluczowa.*